ESZKÖZ 4 / 5

4 Lépéses Klinikai Tervező

Diagnózis → Célok → Mechanika → Kontroll. Kézzel kitölthető, nyomtatható tervezőlap minden esethez.

MIELŐTT KEZDED

Hogyan Használd a Tervezőt?

Minden új esethez nyomtasd ki a lapot; tartsd a páciens kartonjában.

A terv a problémalistából születik. Előbb diagnózis, aztán cél, legvégül mechanika. Ha felborul a sorrend, elhúzódik a kezelés.

1. **1. lépés · Diagnózis** – Töltsd ki az arcot, az okklúziót, a helyanalízist, a kefalometriát és a panorámaröntgent. A panorámához az Eszköz 1-et, az osztályozáshoz az Eszköz 3-at használd. A végén írd le a problémalistát fontossági sorrendben.

2. **2. lépés · Célok** – Minden problémához írj egy célt: arc, moláris és szemfog befejezés, overjet, overbite, középvonal. Az extrakcióról az Eszköz 2-vel dönts; a lehorgonyzási igényt itt határozd meg.

3. **3. lépés · Mechanikai sorrend** – Írd le, milyen sorrendben éred el a célokat. Minden lépésnek megvan az íve vagy kiegészítő készüléke. Pipáld ki, ami kész.

4. **4. lépés · Kontroll és befejezés** – Közbenső panoráma, bracket-újrapozicionálás, az okklúzió 6 kulcsa és retenciós terv. Bracketlevétel előtt minden sornak kipipálva kell lennie.

Szabály

Az üresen maradt sor egy még meg nem hozott döntés. Bracketragasztás előtt az 1. és 2. lépés legyen hiánytalan; utána az Eszköz 5-tel végezd el az utolsó ellenőrzést.

Gyakori hiba

A mechanikai sorrendet megszokásból írni. Előbb transzverzális és ortopédiai korrekció, aztán szintezés; amíg a mélyharapás nincs megnyitva, nem jöhet a szagittális korrekció.

Négyzetek

Jelöld a megfelelő lehetőséget; ha nincs a listán, írd a sor végére.

Módosítás

Ha változik a terv, húzd át a régi sort, és írd mellé a dátumot és az új döntést.

TERVEZŐ · 1. OLDAL

1. lépés • Diagnózis

Amíg nincs meg minden dokumentáció, ne lépj tovább a 2. lépésre.

Páciens / életkor / dátum

Fő panasz

Szokás ☐ Ujjszopás ☐ Szájlégzés ☐ Nyelvlökés ☐ Bruxizmus

Arc

Profil ☐ Egyenes ☐ Konvex ☐ Konkáv

Ajkak ☐ Laza ☐ Erőltetett ☐ Protrúzív ☐ Retrúzív

Arci középvonal / állcsúcs

Mosoly ☐ Sok íny látszik ☐ Széles bukkális folyosó ☐ Normál

Okklúzió

Moláris / szemfog (jobb · bal)

Overjet / overbite (mm)

Középvonal felső / alsó (mm)

Kereszt- / ollós harapás

Spee-görbe ☐ Lapos ☐ Közepes ☐ Mély

Funkcionális csúszás (CR–CO) ☐ Nincs ☐ Van: ___ mm

TMÍ ☐ Nincs lelet ☐ Hang ☐ Fájdalom ☐ Korlátozott nyitás

Hely, kefalometria és dokumentáció

Helyigény felső / alsó (mm)

Bolton-analízis ☐ Arányos ☐ Felső többlet ☐ Alsó többlet

SNA / SNB / ANB · Wits

FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN

Panoráma (Eszköz 1) ☐ Negatív ☐ Van lelet →

Parodoncium / biotípus ☐ Vastag ☐ Vékony ☐ Recesszió van

Növekedési szakasz ☐ Csúcs előtt ☐ Csúcsban ☐ Lezárult

Differenciáldiagnózis (Eszköz 3) ☐ Dentális ☐ Csontos ☐ Pszeudo

Problémalista (fontossági sorrendben)

TERVEZŐ · 2. OLDAL

2. lépés • Célok

Minden problémához egy cél. A cél legyen mérhető.

Arci cél	☐ Profil megtartása ☐ Ajaktámasz csökkentése ☐ Ajaktámasz növelése
Moláris befejezés jobb / bal	☐ I. osztály ☐ Teljes II. osztály ☐ Teljes III. osztály
Szemfog befejezés	☐ I. osztály
Overjet / overbite cél (mm)	
Középvonal	☐ Korrigálni ☐ Elfogadni
Metszőfog-pozíció	☐ Megtartani ☐ Retrakció ☐ Kontrollált proklináció
Transzverzális	☐ Nem kell ☐ RME ☐ Dentoalveoláris tágítás
Vertikális	☐ Megtartani ☐ Mélyharapás nyitása ☐ Nyitott harapás zárása
Extrakciós döntés (Eszköz 2)	☐ Extrakció nélkül ☐ Extrakció: _____
Lehorgonyzási igény	☐ Minimális ☐ Közepes ☐ Maximális
Lehorgonyzás eszköze	☐ TPA ☐ Nance-ív ☐ Mikrocsavar ☐ Gumihúzás

Elfogadott korlátok / kompromisszumok

Elmagyarázva a páciensnek	☐ Lehetőségek ☐ Időtartam ☐ Retenció

TERVEZŐ · 3. OLDAL

3. lépés • Mechanikai Sorrend

Írd le a sorrendet, pipáld ki, ami kész. Amíg egy lépés nincs kész, ne lépj a következőre.

✓	LÉPÉS	ÍV / KÉSZÜLÉK / KIEGÉSZÍTŐ	KEZDÉS DÁTUMA
☐	Ortopédia / tágítás		
☐	Szintezés és rendezés		
☐	Mélyharapás / Spee-görbe		
☐	Résbezárás		
☐	Szagittális korrekció		
☐	Középvonal		
☐	Finomítás (torque, rotáció)		

4. lépés • Kontroll és Befejezés

Kontrollok gyakorisága

Közbenső panoráma (gyökérpárhuzamosság) ☐ Betervezve ☐ Elkészült

Bracket-újrapozicionálás ☐ Nem kell ☐ Fogak: _____

Az okklúzió 6 kulcsa ☐ Moláris ☐ Koronaanguláció ☐ Koronainklináció ☐ Rotáció ☐ Kontaktus ☐ Okkluzális sík

Overjet / overbite / középvonal ☐ Célértéken

Retenció felül ☐ Rögzített lingvális ☐ Hawley ☐ Essix

Retenció alul ☐ Rögzített lingvális ☐ Hawley ☐ Essix

Recidívakockázat / jegyzet

PÉLDA

Kitöltött Példa

Kitalált eset. A saját esetednél elég ugyanilyen részletességgel írni.

1 · DIAGNÓZIS

Páciens	*13 éves lány. Panasz: „Előre állnak a felső fogaim."*
Arc	*Konvex profil, hátul álló állcsúcs; erőltetett ajakzárás*
Okklúzió	*Moláris és szemfog kétoldalt II. osztály; overjet 8 mm, overbite 5 mm; mély Spee*
Hely / Bolton	*Felül 2 mm, alul 3 mm helyigény; Bolton arányos*
Kefalometria	*SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA 97°*
Egyéb	*Panoráma negatív; vastag biotípus; növekedési csúcsban; nincs csúszás*
Diagnózis (Eszköz 3)	*Csontos II. osztály 1. alosztály, mandibuláris retrognathia; konstrukciós harapásban javul a profil*
Problémalista	*1) Szagittális (overjet) 2) Mélyharapás 3) Enyhe torlódás 4) Ajakzárási elégtelenség*

2 · CÉLOK

Arc / szagittális	*Mandibula előrevezetése; moláris és szemfog I. osztály*
Overjet / overbite	*2–3 mm / 2–3 mm*
Extrakció / lehorgonyzás	*Extrakció nélkül (Eszköz 2: az alsó metszőfogak már proklináltak, követendő); közepes lehorgonyzás*
Elmagyarázva a páciensnek	*Funkciós készülék viselése, két szakasz, retenciós időtartam*

3 · MECHANIKAI SORREND

1. Ortopédia	*Twin Block; rendszeres viselési kontroll*
2. Szintezés	*Átállás rögzített készülékre: NiTi sorozat → acél*
3. Mélyharapás	*Spee-görbe korrekciója, frontális intrúzió*
4. Finomítás	*Enyhe II. osztályú gumihúzás szükség szerint; torque és rotáció*

4 · KONTROLL ÉS BEFEJEZÉS

Kontrollok	*Rendszeres időközönként; közbenső panorámán gyökérpárhuzamosság*
Befejezés	*6 kulcs ellenőrzése; overjet és overbite célértéken*
Retenció	*Felül Essix, alul rögzített lingvális; recidívakockázat: alsó metszőfog-proklináció*

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha kitöltötted a lapot, bracketragasztás előtt futtasd át a tervet az **Eszköz 5 · Tervezési Hibák Radarja** segítségével. A tervezés teljes logikája a **Modul 03 · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig** fejezetben van.